Tips del facilitador: Sala 2 · Shock hipovolémico por ectópico roto

Nov 10, 2026 · @ANDRES

Cómo usar esta guía

Este documento es una ayuda para el docente: preguntas para hacerles a los estudiantes en cada fase, con la respuesta esperada y un tip clave. Las cuatro pacientes tienen un ectópico **roto** en la porción ampular de la trompa derecha; cambia la gravedad del shock.

Dato	1 · Sofía	2 · Daniela	3 · Mariana	4 · Andrea
Perfil	22 años, primigestante	34 años, multípara	30 años, secundigestante	27 años, secundigestante
FUM / EG	19 sep · 7 + 3 sem	15 sep · 8 + 0 sem	20 sep · 7 + 2 sem	12 sep · 8 + 3 sem
Fórmula	G1 P0 A0 C0 E0 M0 V0	G5 P1 A1 C1 E1 M0 V2	G3 P1 A1 C0 E0 M0 V1	G2 P0 A0 C1 E0 M0 V1
Ingreso	FC 128 · PA 84/56 · FR 32 · $SatO_2$ 90 %	FC 146 · PA 68/40 · FR 38 · $SatO_2$ 86 %	FC 152 · PA 64/38 · FR 40 · $SatO_2$ 85 %	FC 112 · PA 108/80 · FR 24 · $SatO_2$ 97 %
Mental / diuresis	Ansiosa, confusa · 10 ml/h	Confusa, letárgica · mínima	Letárgica · mínima	Moderadamente ansiosa · 25 ml/h
Hb / Hto	8,2 g/dl · 25 %	6,4 g/dl · 19 %	5,9 g/dl · 18 %	10,6 g/dl · 32 %
Grupo	O +	A +	B +	O +
Grado (ATLS)	III	IV	IV	II
Reposición	Cristaloides y sangre	Cristaloides y sangre	Cristaloides y sangre	Solo cristaloides
Vasopresor	Norepinefrina (PAM 51)	Norepinefrina (PAM 49)	Norepinefrina (PAM 46)	No requiere

Dato	1 · Sofía	2 · Daniela	3 · Mariana	4 · Andrea
Manejo final	Laparotomía	Laparotomía	Laparotomía	Laparotomía

Las situaciones 3 y 4 tienen fases extra: **Ecografía** y **Preparación quirúrgica**; la 4 además cambia Transfusión y Descompensación por **Reevaluación**.

Tip general: asignen roles desde el inicio: líder, vía aérea y monitor, accesos y líquidos, registro y banco de sangre. Hay compresas y equipo para transfusión en la sala.

Preguntas y tips por fase

1. Ingreso

- ¿Qué tríada sospechan? Amenorrea, dolor abdominal y sangrado vaginal en mujer en edad fértil.
- ¿Qué significa el dolor irradiado al hombro de Daniela? Signo de Kehr: hemoperitoneo que irrita el diafragma.
- En Daniela, ¿cómo queda la fórmula? G5 P1 A1 C1 E1 M0 V2: la cesárea cuenta aparte del parto vaginal.
- ¿Qué factores de riesgo tiene Daniela? Ectópico previo, salpingectomía y cesárea.
- ¿Qué preguntan en la anamnesis inicial? Alergias, hora del inicio del dolor, cantidad de sangrado (compresas).

Tip: el sangrado vaginal puede ser escaso aunque el sangrado interno sea masivo. Que no se guíen solo por las compresas.

Ecografía (situaciones 3 y 4)

- ¿Qué ven? Útero vacío, masa anexial derecha de 4 cm y líquido libre abundante en el fondo de saco.
- ¿Qué indica? Ectópico roto con hemoperitoneo.
- ¿Por qué no es un embarazo intrauterino temprano? Con β-hCG positiva y útero vacío, el saco está fuera del útero.
- ¿Qué significa el Blumberg positivo? Irritación peritoneal por la sangre libre.
- ¿La ecografía retrasa la reanimación? No: se hace en la cama mientras el equipo canaliza.

Tip: en Mariana el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria es el factor de riesgo; en Andrea, la cesárea y el cigarrillo.

2. Grado de shock

- ¿Qué parámetros usan para clasificarlo? FC, PA, presión de pulso, FR, diuresis y estado mental.
- Sofía: FC 128, PA 84/56, FR 32, diuresis 10 ml/h, ansiosa y confusa = **grado III**.
- Daniela: FC 146, PA 68/40, FR 38, diuresis mínima, letárgica = **grado IV**.
- ¿Qué dicen la Hb y el Hto? Están bajos frente a la referencia (12–16 g/dl y 36–46 %), pero en sangrado agudo tardan en caer: no reflejan toda la pérdida.
- ¿Cuál es el primer signo de shock? Taquicardia; la hipotensión aparece tarde (grado III).
- Mariana: FC 152, PA 64/38, FR 40, diuresis mínima, letárgica = **grado IV**.
- Andrea: FC 112, PA 108/80 (sistólica normal, presión de pulso de 28 mmHg), FR 24, diuresis 25 ml/h, moderadamente ansiosa = **grado II**. Que noten que la PA “normal” no descarta shock.

Tip: el índice de shock (FC ÷ PAS) ayuda: Sofía 1,5 y Daniela 2,1; mayor de 1 ya indica hipovolemia importante.

3. Reanimación inicial

- ¿Qué hacen primero? Oxígeno para $SatO_2$ mayor de 94 %, monitorización y dos accesos venosos de 16 a 18 G.
- ¿Qué muestras toman al canalizar? Hemograma, hemoclasificación, pruebas cruzadas, β-hCG y coagulación.
- ¿Solo cristaloides o también sangre? En grado III y IV, cristaloides y sangre.
- ¿Por qué abrigarla? La hipotermia empeora la coagulopatía.
- ¿Para qué la sonda vesical? Diuresis horaria como indicador de perfusión; es actividad del equipo, no la prioridad inicial.

Tip: pregunten qué posición le dan: decúbito supino con piernas elevadas si no hay contraindicación.

En Andrea (grado II) la reposición correcta es **solo cristaloides** y el oxígeno “no por ahora”, porque está con $SatO_2$ de 97 %.

Reevaluación (situación 4)

- Tras 1000 ml de cristaloides: FC 96, PA 114/76, diuresis 35 ml/h. ¿Cómo respondió? Respuesta rápida a líquidos.
- ¿Qué hacen? Siguen con cristaloides, reservan sangre y la preparan para cirugía.
- ¿Ya no necesita cirugía? Sí la necesita: el ectópico está roto y puede volver a sangrar.
- ¿Qué los haría cambiar de conducta? Que vuelva la taquicardia o caiga la PA: respuesta transitoria, pasar a sangre.

Tip: es el caso para hablar de la diferencia entre paciente estable y paciente sin riesgo.

4. Transfusión

- ¿Qué verifican antes de conectar la unidad? Paciente correcto, hemocomponente correcto, grupo y Rh correctos.
- ¿Quién verifica? Dos profesionales, en la cama de la paciente.
- ¿Qué acceso usan? Venoso de gran calibre, catéter 18 G.
- ¿Cuándo toman signos? Antes de iniciar y de cerca en los primeros 15 minutos.
- ¿Qué signos indican reacción transfusional? Fiebre, escalofrío, urticaria, disnea, hipotensión o dolor lumbar: suspender y avisar.
- ¿Por qué no microondas ni medicamentos en la bolsa? Hemólisis y contaminación.

Tip: Sofía es O+ y Daniela A+. Pregunten qué sangre recibirían si no hay tiempo para cruzar: O negativo.

5. Descompensación

- ¿Qué es la PAM y cuál es la meta? PAD + (PAS − PAD) ÷ 3; meta mayor o igual a 65 mmHg.
- Si la PAM no sube con líquidos y sangre, ¿qué inician? Norepinefrina (vasopresor).
- ¿Por qué no dobutamina? Es inotrópico; el problema es falta de volumen, no de bomba, y puede bajar más la presión.
- ¿Por qué no furosemida ni labetalol? Bajan volumen o presión: empeorarían el shock.
- ¿La norepinefrina reemplaza la cirugía? No: es un puente mientras se controla el sangrado.

Tip: pregunten qué vigilan con un vasopresor: vía permeable (idealmente central), extravasación, PA y FC continuas.

Preparación quirúrgica (situaciones 3 y 4)

- ¿Qué preparan? Consentimiento informado, reserva de sangre cruzada, retiro de joyas, prótesis y esmalte, entrega a salas y lista de verificación de cirugía segura.
- ¿Por qué preguntar el último alimento? Riesgo de broncoaspiración en la anestesia: Mariana almorzó hace 2 horas.
- ¿Esperan la β-hCG cuantitativa? No: con un ectópico roto no cambia la decisión.
- ¿Enema o rasurado con cuchilla? No: el enema retrasa y la cuchilla aumenta el riesgo de infección.

Tip: que el estudiante haga la entrega a salas en voz alta, con signos, líquidos, unidades, diuresis y medicamentos.

6. Paso a salas

- ¿Cuál es el manejo de un ectópico roto con paciente inestable? Laparotomía urgente.
- ¿Cuándo laparoscopia? En el ectópico mediano, con paciente estable.
- ¿Cuándo metotrexato? En el ectópico pequeño, no roto, con paciente estable.
- ¿Dónde están la mayoría de los ectópicos? En la porción ampular de la trompa (cerca del 80 %).
- ¿Qué entregan al pasar a salas? Signos, líquidos y unidades pasadas, vasopresor en curso, diuresis, consentimiento y reserva de sangre.

Tip: en Daniela pregunten qué implica que ya no tenga la trompa izquierda: si le retiran la derecha, pierde la fertilidad natural. Es un punto para hablar de la comunicación con la paciente.

Cierre (debriefing)

Dediquen los últimos 5 a 10 minutos de cada hora. Preguntas sugeridas:

1. ¿Qué signos les hicieron pensar en shock antes de ver la presión baja?
2. ¿Por qué Sofía es grado III, Daniela y Mariana grado IV, y Andrea grado II?
3. ¿Qué verificaciones de la transfusión les costó recordar?
4. ¿Por qué la norepinefrina es solo un puente?
5. ¿Qué define laparotomía, laparoscopia o metotrexato?

Mensajes clave para cerrar: la taquicardia es el primer signo; grado III y IV requieren sangre; paciente, hemocomponente, grupo y Rh correctos con acceso 18 G; norepinefrina si la PAM sigue baja; ectópico roto e inestable = laparotomía.